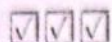


肺化膿症

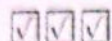
37～42

37★★★★



口腔内・歯肉溝の微生物の誤嚥が原因となることが多い。

38★★★★



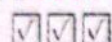
空洞を伴う肺浸潤影が典型的である。

39★★★★



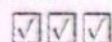
喀痰培養で検出された菌のみを対象として抗菌薬選択を行う。

40★★★★



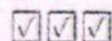
外科的切除と抗菌薬加療の組み合わせが必須である。

41★★★★



免疫不全患者の肺化膿症や抗菌薬治療で改善に乏しい場合、早期の気管支鏡検査を検討する。

42★★★★

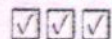


治療反応に乏しい場合、気管支閉塞や悪性腫瘍、血管炎などを鑑別する。

誤嚥性肺炎

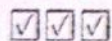
43～48

43★★★★



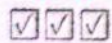
高齢者の肺炎の大半は誤嚥性肺炎である。

44★★★★



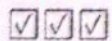
食事中のおせによる顕性誤嚥が原因のほとんどを占める。

45★★★★



診断には誤嚥を直接確認する必要がある。

46★★★★



介護度の高い高齢者の嚥下機能評価では、ベッドサイドでの嚥下機能評価や簡易嚥下誘発試験などの簡易検査を優先する。

